

奥美拉唑的不良反应与药物相互作用分析

冯 茜

(江苏省泗洪县人民医院药材科, 江苏 泗洪 223900)

【摘要】目的 探讨奥美拉唑的不良反应情况与其他药物的相互作用特点。**方法** 医院里2009年1月至2014年1月发表的关于奥美拉唑不良反应的临床资料,对120例患者的临床资料进行统计、分析。**结果** 120例患者中,男性所占比例显著高于女性($P<0.05$);41~60岁年龄段中,男性所占比例显著高于女性($P<0.05$);奥美拉唑ADR主要为全身过敏反应(26.7%)、血液系统(20.8%)及消化系统反应(23.3%),ADR也可累及神口腔、肝肾系统、神经系统。口服给药所占比例显著高于静脉及肌注给药, $P<0.05$,差异有统计学意义。**结论** 临床应用奥美拉唑应充分考虑到其不良反应,由于该药物可对胃酸分泌进行抑制,所以在配伍其他药物时要充分考虑到药物的相互作用情况,以免影响疗效。

【关键词】 奥美拉唑; 药物相互作用; 不良反应

中图分类号: R969.3

文献标识码: B

文章编号: 1671-8194 (2015) 18-0081-02

DOI:10.15912/j.cnki.gocm.2015.18.058

临床治疗胃肠道疾病常会应用到奥美拉唑,奥美拉唑具有良好的胃酸抑制功能。药理作用为^[1]:奥美拉唑能对胃黏膜壁细胞发挥作用,对 H^+-K^+-ATP 酶活性加以抑制,以抑制胃酸分泌。近年来,随着奥美拉唑应用的日益广泛和频繁,关于其不良反应的临床报道也越来越多。本研究旨在分析奥美拉唑的不良反应情况与其他药物的相互作用特点,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:医院里2009年1月至2014年1月的关于奥美拉唑不良反应的临床资料报道,共有病例120例。所有患者均符合药品ADR(不良反应)检测中心的药物ADR诊断标准。其中男性85例(70.8%),女性35例(29.2%),年龄在16~78岁,平均 (42.5 ± 3.2) 岁。

1.2 方法:对120例患者的年龄、性别、不良反应表现、持续时间、临床处理方法、给药方式等情况进行统计分析。

1.3 统计学方法:本次研究数据均应用SPSS18.0软件做统计学处理,

计量、计数资料比较分别采用 t 检验或 χ^2 检验,以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料:120例患者中,男性占70.5%,女性占29.5%,男性所占比例显著高于女性, $P<0.05$,差异有统计学意义;在男性患者中,41~60岁年龄段所占比例显著高于其他年龄段, $P<0.05$,差异有统计学意义;同时41~60岁年龄段中,男性所占比例也显著高于女性($P<0.05$),差异有统计学意义。

表1 两组患者的基线资料比较[n (%)]

性别	例数	年龄			
		20岁以下	20~40岁	41~60岁	60岁以上
男	85(70.8)	2(16.7)	19(15.8)	45(37.5)	19(15.8)
女	35(29.2)	1(0.83)	8(6.7)	12(10.0)	14(11.7)

2.2 不良发应情况:奥美拉唑ADR主要为全身过敏反应、血液系统及消化系统反应,其中全身过敏占26.7%,消化系统反应占23.3%,血

物后,特异性有所下降,同比单一检测,无统计学意义($P>0.05$),具体见表3。

表3 比较单一检测检测与联合检测 (%)

组别	阳性率	准确率	特异性
CYFRA21-1	56.67	78.5	91.1
NSE	41.67	75.1	76.3
CEA	45.00	69.9	70.1
CA125	48.33	69.3	69.5
联合检测	86.50	84.3	75.5

3 讨论

临床中检验肺癌通常采用病理学和细胞学,尽管特异性的检出率有了很大的提升,但是对敏感性仍比较低,很难确切的诊断出早期肺癌患者,当有所发现时会通过病理学或者影像学进行诊断,此时的癌细胞已经开始扩散或者移动了,不仅治疗效果不佳,患者也会承受很大的痛苦^[2]。肿瘤标志物是显示肿瘤存在与生长的重要标志,在肺癌的诊断与治疗中具有一定的临床效果^[3]。

肿瘤标志物一般有四种,即:CYFRA21-1、NSE、CEA、CA125,其自身可以真实的反映出患者肺泡表面的变化,也可以准确的判断出呼吸道上皮及支气管单层上皮存在的肿瘤组织和细胞,但是对不同癌细胞的敏感性也不可一概而论^[3],在本组研究中,单一肿瘤

标志物检测,CEA单一检测率中最大的是腺癌的阳性率(57.14%),CYFRA21-1单一检测率中鳞癌阳性率最大(69.70%),NSE单一检测率中小细胞肺癌阳性率最大(53.85%);四种肿瘤标志物联合检测,阳性率可达到86.5%,准确度达到84.3%,特异性无显著变化。

总之,采用肿瘤标志物联合检测的方法,很大程度上提高了肺癌的阳性检测率,也增强了诊断肺癌的准确性^[4],为以后临床诊断和治疗肺癌提供了参考,具有显著的临床应用效果^[5]。

参考文献

- [1] 邹永红.肿瘤标志物的检验学研究及临床应用价值分析[J].中国医药指南,2013,11(15):557-558.
- [2] 陶华林,李红霞.肿瘤标志物的研究及临床应用进展[J].国外医学(临床生物化学与检验学分册),2005,26(1):54-56.
- [3] 中华医学会检验分会,卫生部临床检验中心,中华检验医学杂志编辑委员会,等.肿瘤标志物的临床应用建议[J].中华检验医学杂志,2012,35(2):103-116.
- [4] 崔巍,李龙芸,崔玉尚,等.多种肿瘤标志物在肺癌细胞上的表达及临床应用[J].中华检验医学杂志,2003,26(9):549-552.
- [5] 周萍,郭炫,陈葳,等.肿瘤标志物联合检测在胸腹水性质鉴别中的临床应用[J].现代肿瘤医学,2014,22(3):664-666.

脂肪肝影响因素的调查浅析

熊玲玲

(南京晨光集团有限责任公司职工医院内科, 江苏 南京 210006)

【摘要】目的 探讨健康体检中脂肪肝检验结果与相关的影响因素。**方法** 选择2012年1月至12月在我院体检4561人做为研究对象, 根据体检的化验结果, 将体检者分为脂肪肝组和健康对照组。**结果** 本次体检的自然人人群中非酒精性脂肪肝比例为22.29%。脂肪肝组的BMI、TG、TC、高血压、糖尿病与健康对照组比较差异有显著性意义 ($P<0.05$)。**结论** 脂肪肝发病与超重、高血压、高血脂、糖尿病等因素有相关性。

【关键词】 健康体检; 脂肪肝; 检验结果; 影响因素

中图分类号: R589.2

文献标识码: B

文章编号: 1671-8194 (2015) 18-0082-02

DOI:10.15912/j.cnki.gocm.2015.18.059

在我国现阶段, 随着物质生活水平的不断提高, 饮食结构的改变及预防干预措施相对落后, 城市居民, 特别是较高收入阶层的脑力劳动者中脂肪肝、高脂血症的发病率不断增加, 另一方面, 少动的生活方式的变化也是导致脂肪肝患病率不断上升的重要原因之一。随着年龄的增长加之内分泌的变化, 脂肪、脂蛋白合成障碍或肝内脂肪利用减弱时, 脂肪累积, 肝脏合成磷脂的水平降低, 从而导致脂肪肝患者随年龄增加而增加的趋势, 如不加强运动量必然引起体内脂肪蓄积, 严重时致病。脂肪肝已成为一种城市常见病, 导致脂肪肝的病因有很

多, 是肝损伤最早的临床表现, 那些能造成人体内脂肪代谢紊乱的因素, 都可能引起脂肪肝的发生^[1]。我们于2012年1月至12月通过对4561例健康体检者脂肪肝的体检结果进行分析, 观察健康人群脂肪肝的影响因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料: 选择2012年1月~12月在我院体检中心进行健康体检的4561人做为研究对象, 男3185例, 女1376例, 年龄25~75岁, 平均年龄 (42.4 ± 12.32) 岁, 根据体检的化验结果将体检者分为脂肪肝组 and

液系统反应占20.8%。另外, 奥美拉唑ADR也可累及神口腔、肝肾系统、神经系统, 具体见表2。

表2 120例患者的ADR情况[n, %]

ADR累及系统或器官	例数	构成比(%)	临床表现
口腔	6	5.0	口腔溃疡
肝肾系统	10	8.3	血尿、肝功异常
神经系统	7	5.8	头痛头晕
血液系统	25	20.8	白细胞计数降低
消化系统	28	23.3	消化不良、腹泻
全身过敏	32	26.7	过敏性休克、皮疹
其他	12	10.0	痛风、心律失常等

2.3 给药途径及ADR发生时间: 120例患者有85例 (70.8%) 为口服给药, 25例 (20.8%) 为静脉给药 (滴注13例、推注12例), 10例 (8.3%) 为肌注给药, 口服给药所占比例显著高于静脉及肌注给药, $P<0.05$, 差异有统计学意义。35例静脉及肌注给药者, 29例在用药后3~5 min发生不良反应, 6例为用药3 d后发生不良反应, 85例口服给药者在用药后3~14 d内发生不良反应。

2.4 临床处理: 所有患者在出现不良反应后, 均立即停药, 症状轻微者在停药后, 症状逐渐消失, 症状严重者在停药后应用地塞米松、非那根、肾上腺素等药物进行对症治疗, 120例患者经及时停药及对症处理, 不良反应均消失, 痊愈出院。

3 讨论

奥美拉唑是新一代胃酸抑制药物, 其不良反应类型较多, 常见的如消化不良、腹泻、皮疹、白细胞减少、心动过速、头晕头痛等, 不良反应严重时还可导致过敏性休克^[2]。本次研究结果显示, 奥美拉唑ADR主要为全身过敏反应、血液系统及消化系统反应, 其发生率分别为26.7%、23.3%、20.8%, 临床表现主要为过敏性休克、皮疹、消化不良、腹泻、白细胞减少。本次研究还显示, 41~60岁年龄段患者所

占比例最高, 且男性明显比女性更高 ($P<0.05$), 这可能是因为该年龄段人群的用药人数较多。

奥美拉唑在与其他药物联用时可发挥协同作用, 临床治疗Hp感染性消化道溃疡常采用奥美拉唑、抗生素联用方案^[3]。但是, 由于奥美拉唑具有较强的胃酸抑制作用, 用药后会使得胃内pH值上升, 每日20 mg的用药剂量即可使胃内pH值维持在6~8, 而部分抗菌药物 (如氨苄西林) 及其酶化物要被人体吸收必须有酸性环境支持, 胃内pH值为6~8时, 会降低其脂溶性, 增加非分子型药物, 破坏酯结构, 四环素在弱碱性环境中可转变为游离四环素, 难以被人体吸收, 从而降低治疗效果^[4-5]。所以, 奥美拉唑在与抗生素联用时, 要避免选用氨苄西林、四环素等。另外, 奥美拉唑还可与地西泮、地高辛、华法林等药物发生作用, 其能使华法林的抗凝作用增强, 缩短地高辛的药效维持时间, 降低地西泮的清除率, 影响治疗效果。

总之, 临床应用奥美拉唑应充分考虑到其不良反应, 同时由于该药物可对胃酸分泌进行抑制, 所以在配伍其他药物时要充分考虑到药物的相互作用情况, 合理配伍, 以免影响疗效。

参考文献

- [1] 谷铁波, 周晓峰, 宋颖, 等. 奥美拉唑不良反应分析[J]. 中国医药导报, 2010, 7(30): 112-113.
- [2] 赵爱华. 奥美拉唑临床不良反应分析[J]. 临床合理用药杂志, 2014, 7(6): 13-14.
- [3] 马丹华, 朱文婷, 徐厚明, 等. 奥美拉唑不良反应及其影响因素分析[J]. 药学与临床研究, 2012, 20(6): 554-556.
- [4] 孙晓霞. 奥美拉唑的临床应用及不良反应[J]. 现代中西医结合杂志, 2009, 18(23): 2865-2866.
- [5] 罗全英, 陈瑛瑛, 王琳, 等. 奥美拉唑在晚期非小细胞肺癌患者化疗中的疗效观察[J]. 南昌大学学报(医学版), 2011, 51(11): 20-22.